EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 84811
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-05-18 15:55:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ENRIQUE DE LAS MERCED FLORES ALVAREZ			**RUN**	: 6.509.001-5
F.Nac	: 11-12-1952	**Edad**	: 71 AÑOS, 5 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: CALLE 1 C/ 27 A PUENTE NUBLE			**Comuna**	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 99886637		
Fecha Ingreso	: 2024-05-12	**Fecha Egreso**	: 2024-05-18 15:55:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia Respiratoria Crónica reagudizada resuelta
- NAC por Influenza A
2. EPOC exacerbado Grupo E / Tabáquico / Ex Fumador.
--Usuario de O2 Domiciliario (3L con concentrador)
--Descompensación de probable causa infecciosa.
3. Hipertensión Arterial
4. Cardiopatia Hipertensiva

Procedimientos invasivos UTI : Línea arterial radial derecha, VMNI (46 hrs), O2 NRC (90 hrs)

<u>DIAGNÓSTICOS CIE10</u>

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. J10.0-INFLUENZA CON NEUMONIA, DEBIDA A VIRUS DE LA INFLUEZA ESTACI (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. F17.1-USO NOCIVO DE TABACO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de tabaquismo cesado, EPOC tabaquico usuario de O2 domiciliario, HTA, cardiopatia hipertensiva, consulta en servicio de urgencia de HSC el 12/05/24 por cuadro de 36 hrs de evolucion de congestion nasal y rinorrea, seguido de intensificación de disnea basal junto con tos con expectoracion escasa mucoide. Durante estas horas paciente sube cantidad de oxigeno en domicilio hasta 5 a 6 litros. Exámenes de laboratorio destaca GSA Ph 7.31 / PCo2 72 / Po2 82
HCO3 36 GB 13300 / PL 206000 / HB 12.6 PCR 33.8. Rx tórax: Sin condensación. Signos de compromiso intersticial , neumonía viral. Panel viral acotado Influenza A positivo. Ingresa a UTI para manejo con VMNI.
Paciente evolucion con hemodinamia autosostenida, ventilando espontaneo, apoyado inicialmente con VMNI durante 46 hrs, con destete progresivo a FiO2 por naricera , mas uso de broncodilatadores y corticoides endovenosos; desde el punto de vista infeccioso parametrosn¿ inflamatorios bajos, completo tratamiento atb con ceftriaxona y azitromicina mas oseltamivir, sin conflicto renal ni metabolico.
Actualmente apoyado con FiO2 por naricera 2 a 3 litros.

Se decide alta a HODOM para continuar con terapia kinesica respiratoria y motora. Reevaluar uso de losartan segun evolucion de PA (durante hospitalizacion normotenso)

PLAN DE MANEJO:

HODOM: KNT Respiratoria y Motora / Reevaluar reinicio de Losartan según Presiones Arteriales.
CONTROL EN 7 DIAS EN SALA ERA DE SU CESFAM

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Régimen Hiposódico
3. O2 para saturar 88-90%
4. Omeprazol 20 mg/día VO
5. Prednisona 20 mg 1 comprimido al dia por 3 dias vo
6. Trelegy 1 puff al día
7. B. Ipratropio 4 puff c/4hrs con aerocámara
8. Salbutamol 2 puff c/6 hrs con aerocámara
9. Atorvastatina 40 mg 1 comprimido por noche vo
10. Bisoprolol 2.5 mg 1/2 comprimido al dia vo
11. Entresto 50 mg 1/4 comprimido al dia vo
12. HODOM: KNT Respiratoria y Motora / Reevaluar reinicio de Losartan según Presiones Arteriales.
13. CONTROL EN 7 DIAS EN SALA ERA DE SU CESFAM

EXÁMENES Y RESULTADOS

Rx tórax: Sin condensación. Signos de compromiso intersticial , neumonía viral

15/05/24: crea 1, PCR 31, ELP 137/4.4/99, INR 0.99, PH 7.36, PCO2 58.5, PO2 81.4.
CSB negativo.

Control en: 7 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

DANIELA VASQUEZ BAHAMONDEZ
MEDICO TRATANTE
16516335-4

JEFE SERVICIO